

Fecha Última Actualización: 11-01-2026 14:46:43

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Claudia Andrea Briones González **Rut** : 13.302.878-1 **N° Archivo** : 2518640
Edad : 48a 1m 26d **Fecha Nacto**: 16/11/1977 **Sexo** : Femenino
Dirección : Camarones 229 Villa Alameda Libertador **Comuna** : Rancagua **Teléfono** : 9 5600 9898

N° Epicrisis
468430

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 01/01/2026 13:53 **Días Estadía**: 10
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad **Fecha Egreso** : 11/01/2026 14:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

DHC secundaria a HAI + CBP, CHILD B7, MELD 26
Ingresa para trasplante hepático

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Diagnóstico:
DHC secundaria a HAI + CBP, CHILD B7, MELD 26
HTP, Varices esofágicas pequeñas, Gastropatía de HTP
Encefalopatía hepática
Resistencia a insulina, HTA
Nódulo suprarrenal Izq con calcificaciones de 21 mm
Alergia a Penicilina
Grupo A +

En tratam con Prednisona 5, Lactulosa 20 cda 8, Carvedilol 6.25 cada 12, Azatioprina 50, Espirinoalctona 50, Furosemida 20, Rifaximina 400 cada 8

TAC abd 27-6-25: Signos de DH, sin lesiones focales hepáticas, circulación colateral, varices esofágicas esplenomegalia de 14 cm

EDA 31-8-25: con Varices esofágicas pequeñas , gastropatía de HTP

Biopsia hepática de 2022 con evidencias de hepatitis autoinmune con actividad necroinflamatoria moderada, Fibrosis avanzada

ECO cardio 3-7-25: ok
Espirometría ok, normal, con PEF 130%
Evaluación por broncopulmonar ok

EDA 04-12-25 no mostró varices

En suma :
DHC secundaria a HAI + CBP CHILD B7, MELD 16
HTP, Varices esofágicas pequeñas, Gastropatía de HTP
Encefalopatía hepática

Fecha Epicrisis : 11/01/2026 14:46

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 11-01-2026 14:46:43

Página 2 de 3

Resistencia a insulina
HTA
Grupo A +

PO THO 2/1/2026

MELD 26 Piggyback clásico, porta TT, AMS a AHD, AMS prox a AHP, VB TT. TIF 05:24, TIC 17 min, Isq Art 40 min, Qx total 4:00.

Solumedrol 750 mg.
Basiliximab 20 mg.
Levo 0.05. Intubada a UCI

Extubada en el primer día postoperatorio
Evolución satisfactoria tolerando dieta liviana
Abdomen blando depresible sin signos peritoneales, se retira drenaje a las 48 hras del trasplante. Sin complicaciones.

Cultivos
01/01/26 Cultivo corriente COCOBACILOS GRAM POSITIVO
01/01/26 Hisopado - Portación de enterobacter NEGATIVO

Otros
VHB Antígeno de superficie NO REACTIVO
VHC Anticuerpos anti virus hepatitis C NO REACTIVO

Doppler día 1
Adecuada permeabilidad de estructuras vasculares

Doppler día 3
Adecuada permeabilidad de estructuras vasculares, leve aumento de índices de resistividad de la AH en el hilio, colección heterogénea adyacente a cisura para ligamento falciforme

Doppler día 7
Adecuada permeabilidad de estructuras vasculares

Evolución
Alerta, consciente, orientada. FC 60 PA 140/80. Dolor controlado. Afebril. Abdomen blando, depresible, sensible a la palpación sin signos de irritación peritoneal. Heridas limpias y secas. Pruebas hepáticas con mejoría para el día de hoy.

Diagnóstico de Egreso

HEPATITIS AUTOINMUNE -
FIBROSIS Y CIRROSIS DEL HIGADO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Alerta, consciente, orientada. FC 60 PA 140/80. Dolor controlado. Afebril. Abdomen blando, depresible, sensible a la palpación sin signos de irritación peritoneal. Heridas limpias y secas. Pruebas hepáticas con mejoría para el día de hoy.

Plan Post Alta

GENERAL
Reposo relativo por 2 semanas, debe caminar evitando reposo prolongado.
Régimen liviano, hipograso
Hidratarse con abundante agua, al menos 2 litros al día.
Mantener apósitos limpios y secos, puede sacarse los parches al 4to día post operatorio.
Se puede bañar. DEBE MANTENER HERIDAS LIMPIAS y SECAS.

FÁRMACOS

-Mantenga medicamentos de uso crónico habitual, tanto en dosis como horarios.

Fecha Epicrisis : 11/01/2026 14:46

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 11-01-2026 14:46:43

Página 3 de 3

- Paracetamol 1 gr vía oral cada 8 horas, por 5 días
- Ketoprofeno 50 mg vía oral cada 8 horas, por 3 días
- Omeprazol 20 mg vía oral cada 24 horas, por 30 días
- Metoclopramida 10 mg vía oral cada 8 horas, si náuseas o vómitos, por 3 días.
- Aciclovir 400 mg vo cada 12 horas por 30 días
- Acido ursodeoxicólico 250 mg vo cada 12 horas por 30 días
- Cotrimoxazol forte 1 comp vo lunes-miércoles y viernes por 30 días
- Elcal D 1 comp vo cada día por 30 días
- Magnatil C tomar 1 comp vo cada día por 30 días
- Tacrolimus 4.5 mg vo cada 12 horas por 30 días
- Prednisona 30 mg vo cada día por 30 días
- Micofenolato mofetil 500 mg vo cada 12 horas por 30 días

CONTROLES

- Control ambulatorio con ROLANDO REBOLLEDO la próxima semana día MIÉRCOLES en CDT Trasplante

Acudir al servicio de urgencias en caso de síntomas de alarma como: Fiebre ($T^{\circ} > 38^{\circ}\text{C}$), dolor abdominal que no cede con analgesia, enrojecimiento de heridas asociado a secreción purulenta. Vómitos abundantes, sangrado abundante o SOS según estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Tamara Ailee Alvarez Veliz
Médico Tratante (Staff)